

FRACTURAS DE TERCIO MEDIO FACIAL

Gema Arenas de Frutos, Raúl Antúñez-Conde, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno

INTRODUCCIÓN

La región facial constituye un área de vital importancia tanto en funcionalidad como estética, siendo origen en raras ocasiones de lesiones potencialmente mortales. No obstante, lesiones a nivel del territorio medio facial pueden estar asociadas a lesiones tanto intracraneales como oculares que sí constituyen situaciones de emergencia.

Dividimos las fracturas de tercio medio facial en:

- **Fracturas nasales**
- **Fracturas malares / orbitomalares**
- **Fracturas maxilares**

Fracturas malares / orbitomalares

El hueso malar o cigomático es un hueso en forma de pirámide que constituye una de las áreas más prominentes de la cara, motivo por el cual es origen habitual de lesiones postraumáticas a dicho nivel.

Existen numerosas clasificaciones de este tipo de fracturas, basadas en criterios anatómicos o en relación con la cantidad de energía.

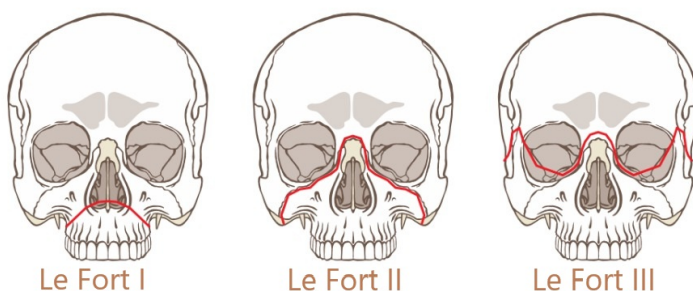
En resumen podríamos contemplar:

- Fracturas simples del **arco cigomático/malar** (fractura-hundimiento).
- **Disyunción del complejo cigomático** (fractura a nivel de las suturas que unen este hueso a los adyacentes, asociadas a desplazamientos en grado variable).
- **Disyunción asociada a fractura malar** (grado de conminución variable).

Fracturas maxilares

De menor a mayor grado de complejidad podríamos clasificar las fracturas maxilares en:

- Fracturas de las **paredes del seno maxilar** (anterior, lateral o posterior), muy frecuentes dada la fragilidad de esta estructura anatómica.
- **Fracturas palatinas** (raramente aisladas) y **dentoalveolares**.
- Fracturas tipo **Lefort**:
 - **Fractura de Le Fort I (horizontal) o Tipo I**: fractura horizontal del maxilar.
 - **Fractura de Le Fort II (piramidal) o Tipo II**: fractura piramidal, que se extiende desde la pirámide nasal, hacia las paredes mediales orbitarias y en continuidad al maxilar.
 - **Fractura de Le Fort III (transversal) o Tipo III**: disyunción craneofacial, similar a la anterior pero involucrando también las paredes laterales orbitarias.



DIAGNÓSTICO

La clínica será variable en función de la estructura afectada. Habitualmente comprenderá **dolor** regional, **epistaxis** (fractura nasal o fractura de paredes de senos maxilares/etmoidales, por disrupción mucosa), **limitación de apertura oral** (típicamente en fracturas de arco cigomático), **disoclusión / maloclusión**, **enfisema subcutáneo** (en fracturas de senos asociadas a maniobras de Valsalva), **alteraciones sensitivas** (hipoestesia de V2 (rama infraorbitaria del nervio trigémino), típicamente afectada en fracturas de suelo orbitario o pared anterior de seno maxilar) o incluso **compromiso/colapso de vía aérea superior** (en casos de fracturas tipo Lefort severas).

La exploración física comprenderá la **inspección visual** y la **palpación** de estructuras extra e intraorales, en busca de asimetrías de contornos faciales (incluida distopía en fracturas orbitomales), **hundimientos óseos** o visualización de **heridas o hematomas en mucosa oral** que pueden ser indicativos de lesiones óseas subyacentes. La **maniobra de Lefort** (tracción anterior del maxilar en orden a descartar movilidad) será también obligatoria.

Las pruebas complementarias utilizadas en el diagnóstico de confirmación de estas fracturas incluyen:

- **Radiología simple** (proyección de Waters, Hirtz o Cadwell).
- **TAC Craneo-facial sin contraste** es la prueba de elección para confirmar las fracturas y para el estudio de las mismas (obligatoria en caso de alta sospecha y mecanismo lesional).
- Según estado clínico del paciente incluiremos analítica básica: hemograma, bioquímica y coagulación.

TRATAMIENTO

Las fracturas de tercio medio facial **rara vez precisan un manejo quirúrgico urgente**, siendo diferido el tratamiento definitivo en caso de precisarse (reducción y osteosíntesis) habitualmente entre 5-7 días (disminución de inflamación).

Fracturas orbitomales complejas (compromiso orbitario) y fracturas tipo Lefort en las que exista potencial compromiso de vía aérea por movilidad fractuaria (manejo ABCDE, pueden precisar la realización de traqueotomía urgente), así como heridas complejas precisarán la evaluación de un cirujano maxilofacial de manera urgente.

Descartadas estas situaciones, el manejo terapéutico de estas fracturas en Urgencias comprenderá:

- **Analgesia y terapia antiinflamatoria.** Incluida corticoterapia en casos de edema moderado/severo, siendo recomendable pauta descendente domiciliaria.
- **Antibioterapia.** Habitualmente Amoxicilina-clavulánico vs Clindamicina en alérgicos a la penicilina hasta completar 7 días de tratamiento en casos de afectación de senos paranasales o heridas intraorales.

En la mayoría de las ocasiones estos pacientes podrán ser altados del servicio de Urgencias tras el diagnóstico, siendo derivados para **evaluación diferida por el cirujano maxilofacial**.

Las **recomendaciones domiciliarias**, además del tratamiento médico ya indicado, incluirán la dieta oral blanda/túrmix, el hielo local, la estricta higiene oral, el reposo nocturno con el cabecero elevado, así como la evitación de traumatismos locales y de las maniobras de Valsalva en caso de fracturas de senos paranasales (estornudos, sonado nasal, buceo,...).

Puntos clave

- Las fracturas del tercio medio facial rara vez suponen situaciones de compromiso vital, pero obligan a descartar lesiones intracraneales u oculares que sí constituyen situaciones de emergencia. Habitualmente precisan un manejo domiciliario conservador.
- Fracturas tipo Lefort inestables suponen un riesgo de compromiso de vía aérea, precisando la valoración urgente por el cirujano maxilofacial.

BIBLIOGRAFÍA

- Martín Granizo R, López Davis A. Cirugía Oral y Maxilofacial. Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 3ª ed. Barcelona: Médica Panamericana; 2011.
- García Marín F, Ochandiano Caicoya S. Cirugía oral. Carlos Navarro Vila. 2ª ed. Madrid: Aran; 2009.